

INTERVIEW PRESENTATION

대표 프로젝트 성과와 DAI 플랫폼 구축 기여 방안

AI 헬스케어 플랫폼 팀장 지원

정치성 · 2026.09.16

사용자와 현장의 문제를 제품과 운영의 개선으로 연결해 온 경험

복잡한 요구를 서비스 정책과 업무 흐름으로 구체화하고, 팀의 실행으로 연결해 왔습니다.

경험 · 도메인	사용자가 완료할 일	현장의 처리 업무	무엇을 증명하나
굿리치 보험 · 인슈어테크	USER 보험분석을 위한 상담신청	→ OPS 상담 활용 정보의 품질 확인	전환
THK 장기요양 · 돌봄	USER 수급자 자격·구매 정보 조회	→ OPS 주문·직배송의 확인과 예외 처리	운영
더베스트페이 병원 원무	USER 예약·조회·수납	→ OPS EMR 연동과 기관별 요구 조율	연동
코나아이 지역화폐 · 결제	USER 지역화폐·카드 이용	→ OPS 3개 팀 요청의 우선순위·실행 관리	조직 실행

수렴점 네 현장 모두 — 사용자가 할 일과 현장의 처리 업무를 함께 설계한 하나의 일관된 플랫폼 역량

보험분석 상담신청 페이지 전환율 20% 개선

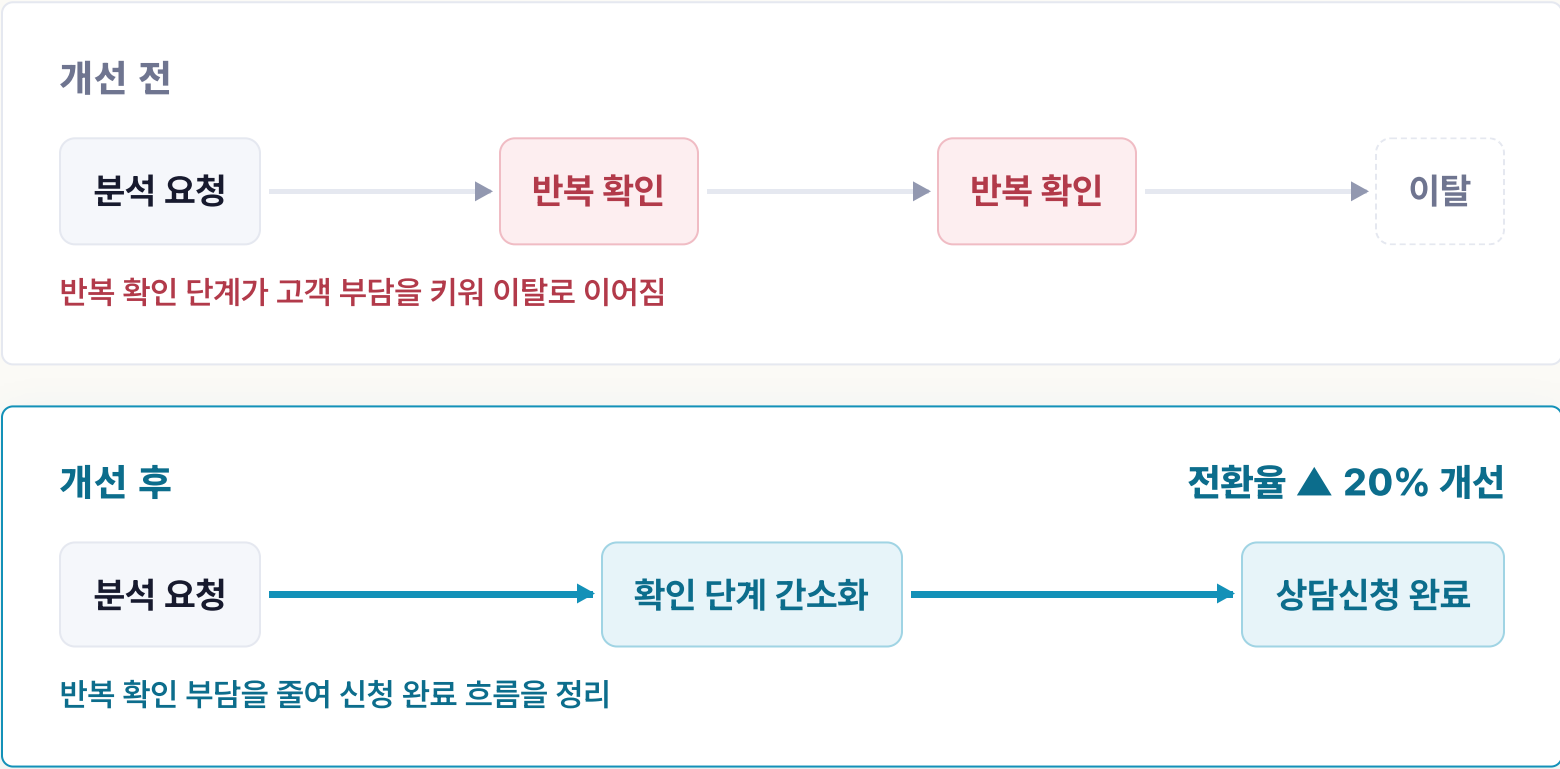
— 페이지 수정 전 대비, 해당 페이지의 상담신청 전환율

20% 개선

보험분석 상담신청 페이지의 상담신청 전환율,
수정 전 대비 개선

문제	상담신청 과정의 반복 확인 단계가 고객 부담·이탈 요인
실행	반복 부담을 확인하고, 확인 단계와 신청 흐름을 개선
결과	수정 반영 후 전환율 기존 대비 20% 개선
함께 확인	설계사 클레임 비율 점검 — 상담 활용 정보 품질

신청 과정 개념도 · 실제 화면 아님



직배송 확인 업무를 시스템으로 구조화

— 일일 처리업무 약 6시간 → 약 2시간 · 고물량 제조사 적용 구간 기준

개선 전	재고 미보유 주문의 수기 확인 ·제조사 개별 연락, 진행·예외 확인에 업무 집중
본인 변경	주문 상태·처리 흐름 을 정리하고, 담당 업무·예외 처리를 관리자 시스템에 반영
적용	제조사별 운영 여건에 맞춰 적용

약 30%

보조 근거 · 수급자 조회·관리 기능 이용률
수급자 자격·급여 기준·구매 정보 조회·관리 기능을 함께
고도화

일일 처리업무 시간 비교 · 고물량 제조사 적용 구간 기준



EMR API와 환자 이용 흐름을 연결한 원무 서비스 기획



1

원무 모바일 서비스
환자 이용 흐름 · 운영 확인 · 예외 처리 고려

▲ 기존 API 연동 (수행)

2

기존 EMR API
업체가 제공하는 데이터·기능 범위

▲ 원무 절차 기반 기능 검토·조율 (수행)

3

병원 원무 절차
병원·EMR사·개발조직 요구사항 조율

제안 · 검토 (수행 아님)

반복 기능의 공통화

병원 공통 통합 플랫폼 방향

완성한 성과가 아니라, 검토·제안 단계

수행 경험 — 기존 API 기반 기획·조율 제안 · 검토 — 공통화·통합 방향	병원별 차이 기관마다 요구사항이 다름	EMR 업체별 차이 제공 데이터·기능이 상이	추가 개발·협의 협의·비용이 별도로 필요
---	--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

여러 사업의 요청을 우선순위와 팀별 책임으로 정리

본인 · 팀장
3개 팀 운영

코나카드	직접 겸직
지역화폐	팀장 중심 운영
모빌리티	팀장 중심 운영

우선순위 판단 기준

- 외부와 합의한 일정·약속
- 법률·운영 위험
- 여러 요청을 함께 해결할 공통 과제

실행 관리

- 업무 배분과 백로그 정리
- PRD 목적·KPI ↔ 상세기획 연결 확인
- Figma 기반 산출물 공유·협업

DAI 적용 어려운 요구가 생기면 범위·일정·내부 인력·외부 협업의 선택안을 비교하고, 경영진 판단이 필요한 사안에는 추천안을 제시하겠습니다.

AI로 요구사항을 구체화하고, 적용 효과와 운영 품질을 함께 검토

지금까지 · 수행 · 만든다

AI로 앞단을 구체화

- PRD · 기능정의 · 프로토타입 제작
- 테스트 데이터를 연결한 작동 프로토타입
- 사내 운영 업무의 도구화 · 자동화



DAI · 적용 · 판단한다

정식 적용은 4가지 기준으로

- 효과** 어떤 사용자·운영 문제를 개선하는가
- 오류·누락** 결과의 오류·누락을 어떻게 확인하는가
- 사람 검토** 어떤 상황에서 사람이 검토하는가
- 비용** 데이터·연동·보안·운영 비용을 감당할 수 있는가

적용 예시

정보 요약 기능이라면 — 처리시간과 중요 정보 누락 여부를 함께 평가

향후 접근법입니다. 실제 의료 AI 프로젝트 성과가 아닙니다. 임상·규제 판단은 관련 전문가와 협업합니다.

사업 목표와 실행 조건에 따라 검증하고 확장

1 사업 · 현장 이해 ? 실제 사용자·도입 결정자·비용 주체와 기존 데이터·계약 조건은? 판단 결과 해결할 문제와 기대 성과 합의	2 우선 과제 선정 ? 고객 영향·사업 효과와 데이터·개발·운영 가능성은? 판단 결과 우선순위와 개발 범위 제안	3 불확실성 검증 ? 수요·연동·AI 품질·운영 중 핵심 불확실성은 무엇인가? 판단 결과 진행 · 범위 수정 · 보류 판단	4 구축 · 개선 · 확장 ? 실제 이용·운영 결과와 공통 활용 가능한 기준은? 판단 결과 보완 · 확대 여부 결정
--	---	---	---

← 검증 결과에 따라 앞 단계로 되돌아갈 수 있고, 이미 검증된 부분은 이어받습니다

경영진에게는 **선택의 근거와 추천안**을, 실행 조직에는 **명확한 범위와 판단 기준**을 제시하겠습니다.

먼저 증명할 두 가지 실행 가설

① 접점을 하나의 여정으로 잇고 → ② 그 데이터를 표준화해 개선에 재사용한다

① 가설 A · 환자 경험 연결(접착제)
진단·모니터링·관리를
하나의 환자 여정으로 잇는다

가설	지금은 접점이 따로 쓰인다 — 만성질환 사용자에게 측정 → 해석 → 다음 행동 이 한 여정으로 이어지면 측정 지속·후속 연결이 좋아진다
근거	그룹은 진단·모니터링·관리 접점(닥터눈·하이카다·케어센스케어 등)을 이미 확보 — 잇는 ‘환자 경험 레이어’ 가 빈자리
검증	만성질환군 소수 대상, 두 접점을 잇는 얇은 슬라이스 로 측정 지속·다음 행동 연결 관측
성공·중단	측정 지속·행동 연결↑ + 안전 인시던트 0 + 동의·규제 통과 → 확장 / 미달 → 축소·보류



② 가설 B · 데이터 플라이휠(RWD) C
여정에서 쌓인 데이터를
표준화해 개선에 재사용한다

가설	접점을 잇는 과정의 이용·측정 데이터를 표준 형식으로 축적 하면, 다음 서비스 개선·근거의 토대로 재사용되어 개선이 빨라진다
근거	접점이 따로 돌면 데이터도 흩어진다 — 상호운용 표준 기반 ‘데이터 레이어’ 가 재사용의 전제
검증	한 여정에서 최소 공통 데이터 표준 (동의·항목·포맷)을 정의하고, 수집 → 재사용 파이프라인을 소규모 실증
성공·중단	데이터 완결성·재사용 가능성 확인 + 동의·보안·규제 통과 → 확대 / 미달 → 표준 범위 재조정

두 가설은 “접점을 잇고 → 거기서 쌓인 데이터를 재사용”으로 이어집니다. 확정이 아니라 **입사 후 초기 진단**으로 갱신하며, 데이터 활용은 **환자 동의·보안·규제 범위 확인이 전제**입니다. 특정 환자 데이터 사용 권한을 이미 확보했다고 가정하지 않고, 임상·규제 판단은 전문가와 함께합니다.

CLOSING

DAI의 사업 과제를 제품과 운영으로 구체화하겠습니다

01 전환

사용자 행동과 사업 전환을 함께 본 경험

02 연동

현장 업무와 외부 시스템을 연결한 경험

03 실행

우선순위를 정하고 여러 팀의 실행을 이끈 경험

필요한 전문성과 협업하며, 판단의 근거와 실행 결과를 끝까지 설명하는 팀장이 되겠습니다.